Povorcitinib oral en vitíligo: ¿cuánto repigmenta un inhibidor de JAK1 en un año?

Ezzedine K, Lui H, Eleftheriadou V, Desai SR, Passeron T, Ringuet J, et al. Povorcitinib for nonsegmental vitiligo: two randomized, controlled, phase 3 STOP-V trials. *Nat Med*. 2026 (publicado en línea). doi:10.1038/s41591-026-04739-2

Versión 1.0 · Revisado el 3 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Todavía no
El artículo lo describe como un fármaco en evaluación y no informa aprobación regulatoria. Se suma a la evidencia fase 3 de inhibidores de JAK orales en vitíligo (p. ej., upadacitinib, Viti-Up).

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Sí, dentro del ensayo
Dos ECA idénticos, doble ciego, con 916 pacientes y análisis por intención de tratar. El efecto se replicó en ambos.

CUIDADO AL INTERPRETAR
1 de cada 5 en la cara
F-VASI75 en 18.9 %. En el cuerpo, T-VASI75 apenas en 2–3 %. Solo hay 52 semanas de seguridad, y el patrocinador participó en el análisis y la redacción.

En 30 segundos. STOP-V1 (467 pacientes) y STOP-V2 (449) son dos ensayos fase 3 de diseño idéntico: **povorcitinib 30 mg una vez al día** (inhibidor oral selectivo de JAK1) contra placebo durante **52 semanas** en adultos con vitíligo no segmentario moderado a grave y afectación facial. Desenlace primario: mejoría ≥75 % en el índice facial (**F-VASI75**). Lo alcanzó el **18.9 % vs. 6.8 %** en STOP-V1 (OR 3.1) y el **18.9 % vs. 3.1 %** en STOP-V2 (OR 7.5). En todo el cuerpo, la mejoría ≥50 % fue de 13–18 % vs. 5–7 %, y la ≥75 %, de 2–3 %. La repigmentación seguía aumentando a la semana 52. El evento adverso con más exceso sobre placebo fue el acné (~11 % vs. 2–3 %). Hubo 4 carcinomas basocelulares y un paciente con TEP y TVP en el grupo de povorcitinib; no hubo MACE, tuberculosis ni muertes.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Cómo leer un ensayo con desenlace de "respondedores": qué es un umbral como VASI75, cómo cambia el resultado según cómo se imputan los datos faltantes, por qué el OR se ve más grande que el riesgo relativo y cómo traducirlo a NNT. Además: qué aporta tener dos ensayos gemelos y cómo leer el papel del patrocinador.

1 La pregunta clínica (PICO)

POBLACIÓN	Adultos (≥18 años) con vitíligo no segmentario, área facial afectada ≥0.5 % (F-VASI ≥0.5) y área corporal total ≥5 % (T-VASI ≥4; sin límite superior), candidatos a terapia sistémica según el investigador. Mediana de edad de 46 a 48 años, 55–57 % mujeres, 79–85 % blancos, 23–27 % con fototipo IV a VI. La mayoría tenía la enfermedad desde hacía más de 10 años (~70 %), era estable (61–71 %) y tenía un T-VASI medio de 19.5 a 23. Hubo 149 centros en Norteamérica, Europa y Japón, incluido México en STOP-V1.
INTERVENCIÓN	Povorcitinib 30 mg VO una vez al día, en monoterapia. Se prohibieron la fototerapia, los tratamientos tópicos para vitíligo y otros inmunomoduladores. Se permitieron emolientes, maquillaje de camuflaje y protector solar, y no se restringió el sol natural.
COMPARADOR	Placebo una vez al día durante 52 semanas, sin rescate. Después, extensión abierta de 52 semanas con povorcitinib para todos, aún en curso.
DESENLACES	Primario: F-VASI75 a la semana 52. Secundarios clave, en orden jerárquico: cambio porcentual del T-VASI, T-VASI50, escala de notoriedad facial (VNS) de 4 o 5 ("mucho menos notorio" o "ya no se nota") y T-VASI75. También calidad de vida, ansiedad y depresión, y seguridad.

2 Diseño

TIPO	Dos ECA fase 3, multicéntricos, doble ciego, controlados con placebo, aleatorización 1:1 estratificada por F-VASI, T-VASI y fototipo (NCT06113445 y NCT06113471). Reclutamiento de noviembre de 2023 a marzo de 2025.
DOSIS	En fase 2 no hubo una relación clara entre dosis y eficacia (15, 45 y 75 mg). Se eligió 30 mg con modelos de exposición-respuesta, buscando eficacia similar a las dosis altas con mejor perfil de seguridad.

ESTADÍSTICA	Intención de tratar. Se calculó un 95.6 % de poder para detectar 20 % vs. 8 % en el desenlace primario. Las pruebas siguieron un orden fijo (*gatekeeping*) para controlar el error tipo I. Datos faltantes con imputación modificada de no respondedores (mNRI): quien inició una terapia prohibida contó como no respondedor; los demás faltantes se imputaron por imputación múltiple. Hubo 3 análisis de sensibilidad (NRI, imputación múltiple, regresión logística longitudinal) y 1 de apoyo en población por protocolo.
FINANCIAMIENTO Y CONFLICTOS	Financiado por Incyte, que participó en el diseño, la recolección, el análisis, la interpretación, la redacción y la decisión de publicar. Cuatro autores son empleados de Incyte. El borrador inicial lo redactó Sorcero, Inc. con un proceso propio de inteligencia artificial, por encargo y con financiamiento de Incyte.

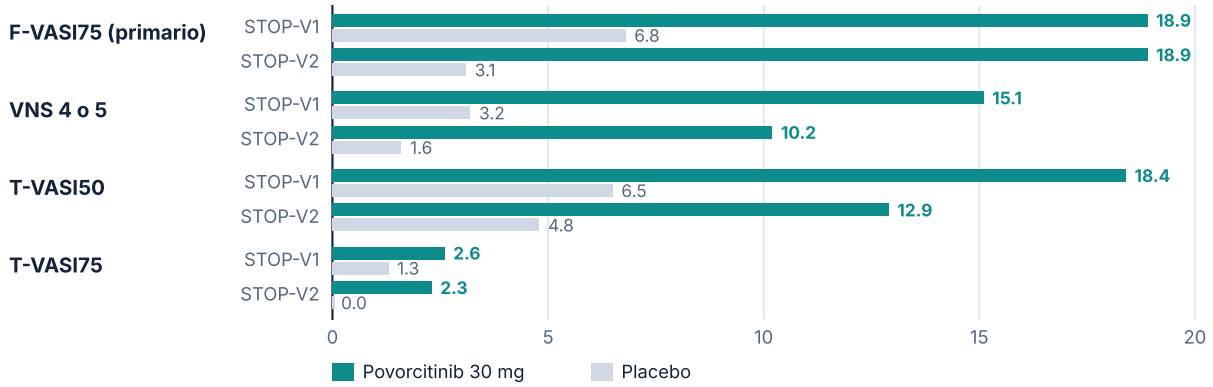
3 Resultados

Completaron las 52 semanas el 82.2 % (STOP-V1) y el 82.9 % (STOP-V2), con abandono similar entre grupos; la causa más frecuente fue el retiro voluntario.

DESENLACE A LA SEMANA 52	STOP-V1: POVORCITINIB VS. PLACEBO	STOP-V2: POVORCITINIB VS. PLACEBO
F-VASI75 (primario)	**18.9 % vs. 6.8 %**; OR 3.1 (1.6–5.9)	**18.9 % vs. 3.1 %**; OR 7.5 (3.0–18.6)
Cambio del T-VASI	−24.1 % vs. −5.7 %; diferencia −18.4 (−24.0 a −12.8)	−21.1 % vs. −4.4 %; diferencia −16.8 (−21.9 a −11.7)
T-VASI50	18.4 % vs. 6.5 %; OR 3.2 (1.7–6.2)	12.9 % vs. 4.8 %; OR 2.9 (1.3–6.4)
VNS 4 o 5 (percepción del paciente)	15.1 % vs. 3.2 %; OR 5.2 (2.2–12.5)	10.2 % vs. 1.6 %; OR 7.5 (2.2–25.6)
T-VASI75	2.6 % vs. 1.3 %; OR 2.0 (0.5–8.2); **p = 0.35**	2.3 % vs. 0 %; OR no evaluable; p = 0.039
F-VASI50 (observado)	35.8 % vs. 16.0 %	43.5 % vs. 11.4 %
F-VASI90 (observado)	8.8 % vs. 3.2 %	7.5 % vs. 0 %

OR con IC 95 %. Primario y secundarios clave con imputación (mNRI o imputación múltiple); F-VASI50 y F-VASI90, datos observados de la tabla extendida 1. La ansiedad y la depresión (HADS) cambiaron muy poco.

Respondedores a la semana 52 (%): povorcitinib vs. placebo



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos mNRI (intención de tratar) del texto y de las figuras 2 y 3 del artículo; no reproduce figuras originales.

SEGURIDAD (52 SEMANAS)	STOP-V1: POVORCITINIB VS. PLACEBO	STOP-V2: POVORCITINIB VS. PLACEBO
Cualquier evento adverso	68.7 % vs. 63.7 %	66.7 % vs. 62.7 %
Relacionado con el fármaco (según el investigador)	30.9 % vs. 21.4 %	33.3 % vs. 18.7 %
Acné	10.7 % vs. 3.0 %	10.8 % vs. 2.2 %
Elevación de CPK	6.9 % vs. 3.4 %	6.3 % vs. 6.7 %
Hipercolesterolemia (como evento adverso)	0.9 % vs. 0.4 %	5.0 % vs. 0 %
Grave	2.1 % vs. 2.1 %	3.6 % vs. 3.1 %
Suspensión por evento adverso	5.2 % vs. 4.3 %	6.3 % vs. 2.2 %

Eventos de clase de los inhibidores de JAK	Sin MACE, tuberculosis ni muertes; ninguna perforación intestinal con povorcitinib. Infecciones graves: 3 vs. 0 (STOP-V1) y 0 vs. 2 (STOP-V2). Las 2 neoplasias no cutáneas fueron con placebo. Carcinoma basocelular en 4 pacientes con povorcitinib (0 con placebo); 2 de los 4 tenían fototerapia previa y uno, además, antecedente de cáncer de piel. Un paciente con povorcitinib tuvo TEP, TVP y várice trombosada (con tabaquismo, várices, HTA, AR e infección reciente por *Mycoplasma*). Herpes zóster: 2 vs. 2 (STOP-V1) y 1 vs. 0 (STOP-V2). Sin cambios relevantes en hemoglobina, plaquetas ni transaminasas.

4 Cómo leer estos resultados

- **Funciona, pero en una minoría.** DATO DEL ARTÍCULO F-VASI75 en 18.9 % en ambos ensayos, algo menos de lo que asumía el cálculo de muestra (20 % vs. 8 %), con un placebo igual o más bajo de lo previsto (6.8 % y 3.1 %). INTERPRETACIÓN En diferencia absoluta son 12.1 y 15.8 puntos: un NNT aproximado de 9 y 7 para que un paciente más repigmente ≥75 % la cara en un año. El 81 % no llega a esa meta en 52 semanas.
- **La cara responde mejor que el cuerpo.** DATO DEL ARTÍCULO T-VASI75 fue de 2–3 % y no fue significativo en STOP-V1. Los autores lo atribuyen a que la repigmentación es lenta y las curvas no se aplanaban a la semana 52. INTERPRETACIÓN El cálculo de poder asumía un T-VASI75 de 7 % vs. 2 %; el observado fue ~2.5 %. Que siga subiendo después de la semana 52 es una hipótesis que la extensión abierta, sin placebo, no podrá confirmar del todo.
- **Dos ensayos gemelos valen más que uno grande.** DATO DEL ARTÍCULO El efecto primario se replicó con la misma magnitud de respuesta. El placebo respondió más en STOP-V1. Los autores dicen que la causa se desconoce; proponen que la enfermedad más extensa en STOP-V2 pudo bajar su placebo, y que más fototipos I–II (más difíciles de evaluar) y más centros en STOP-V1 (81 vs. 68) pudieron aumentar la variabilidad. INTERPRETACIÓN Por eso las medidas relativas "saltan" (OR de 3.1 a 7.5; RR de ~2.8 a ~6) con la misma respuesta en el brazo activo: con un placebo bajo, pequeñas diferencias en él mueven mucho cualquier cociente. La diferencia absoluta cambia menos (12.1 vs. 15.8 puntos).
- **Lo que percibe el paciente acompaña a lo que mide el médico.** DATO DEL ARTÍCULO VNS 4 o 5 (10–15 %) se acercó a F-VASI75. Un análisis *post hoc* sugirió menos progresión con povorcitinib (sin aumento del T-VASI ni lesiones nuevas). INTERPRETACIÓN El análisis *post hoc* genera hipótesis, no conclusiones.
- **Seguridad: tranquiliza, pero es corta.** INTERPRETACIÓN Son 52 semanas en ~455 expuestos, con exclusión de personas con trombosis previa, alto riesgo cardiovascular (en la UE) o infecciones crónicas activas. Con 0 MACE en ese número, el riesgo real aún podría llegar a ~0.7 % al año (regla del 3), y no se pueden descartar eventos raros de clase (MACE, trombosis, cáncer) que en otros inhibidores de JAK aparecieron en estudios más largos y en poblaciones de mayor riesgo.

CONCEPTO CLAVE · DESENLACES DE RESPONDEDORES, IMPUTACIÓN Y OR

Respondedor: convertir una escala continua (VASI) en "sí/no" a un umbral (75 %) facilita la lectura clínica, pero pierde información. El cambio porcentual del T-VASI (−21 a −24 % vs. −4 a −6 %) complementa ese panorama. **Datos faltantes:** con 17–18 % de abandono, la forma de imputar importa. La NRI clásica cuenta a todo el que falta como no respondedor (conservadora). La mNRI solo lo hace con quien usó una terapia prohibida y, para el resto, estima su respuesta por imputación múltiple. Con NRI clásica, F-VASI75 fue de 16.3 % vs. 6.0 % y de 16.1 % vs. 2.7 %: la conclusión no cambia, y el análisis por protocolo también fue concordante. **OR vs. riesgo relativo vs. NNT:** 18.9 % vs. 3.1 % es un OR de 7.5, pero un riesgo relativo de ~6 y una diferencia absoluta de 15.8 puntos (NNT ≈7). El OR supera al RR porque la respuesta con povorcitinib (~19 %) no es rara; solo se aproximan cuando el evento es poco frecuente (<10 %). Para decidir con el paciente, la diferencia absoluta y el NNT son más útiles que el OR. ***Gatekeeping*:** los secundarios se prueban en orden y solo si el anterior fue significativo, lo que protege contra hallazgos por azar.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Aleatorización y cegamiento	Doble ciego (pacientes, investigadores y patrocinador) durante 52 semanas; estratificación por gravedad y fototipo.	Confirmado
● Replicación	Dos ensayos independientes con el mismo diseño y resultado primario concordante.	Confirmado
● Multiplicidad	Secuencia jerárquica fija para primario y secundarios clave.	Confirmado
● Sin comparador activo	Solo placebo: no se puede comparar con fototerapia, ruxolitinib en crema u otros inhibidores de JAK.	Reconocido por los autores
● Monoterapia	En la práctica se combinan tratamientos (p. ej., con UVB de banda angosta); no se evaluó la combinación.	Reconocido por los autores

Población	80–85 % blancos y criterios de exclusión estrictos; puede no reflejar a pacientes con comorbilidades. Se incluyeron todos los fototipos, sobre todo II a IV.	Reconocido por los autores
Duración	52 semanas controladas; la eficacia máxima y la seguridad a largo plazo quedan para la extensión abierta.	Reconocido por los autores
Patrocinio	El patrocinador participó en todo el proceso y el borrador inicial se redactó con un proceso de IA financiado por él. Todos los autores declaran haber tenido acceso a los datos incluidos y verificarlos; solo 6 tienen acceso a los datos crudos, 4 de ellos empleados de Incyte.	Declarado

Pregunta de repaso: hombre de 38 años con vitíligo no segmentario estable desde hace 12 años, ~20 % de superficie corporal y lesiones en la cara que le afectan socialmente. Leyó sobre "la pastilla para el vitíligo" y pregunta si le servirá. ¿Qué le dices con base en STOP-V?
Respuesta. Que en su perfil (enfermedad extensa y de larga evolución, como la mayoría de los participantes), en un año alrededor de 1 de cada 5 logró repigmentar ≥75 % de la cara, contra 3–7 % con placebo. Entre quienes llegaron a la evaluación de la semana 52, el 36–44 % repigmentó al menos la mitad de la cara (11–16 % con placebo; datos observados, sin imputar). En el resto del cuerpo, la repigmentación casi completa fue rara (2–3 %). La mejoría es lenta y seguía aumentando al año. El efecto adverso con más exceso sobre placebo fue el acné (~11 % vs. 2–3 %); la CPK elevada fue casi siempre asintomática y ligada al ejercicio. Los eventos graves de clase fueron raros, pero solo hay un año de datos.[1] El artículo lo describe como un fármaco en evaluación, así que hoy no es una opción de rutina. Las alternativas disponibles se eligen según las guías de vitíligo, y este ensayo no se comparó con ellas.

¿Qué aprendí de medicina?

- Povorcitinib 30 mg: F-VASI75 en 18.9 % vs. 3–7 % a 52 semanas.
- En el cuerpo, la repigmentación casi completa fue rara (2–3 %).
- La repigmentación es lenta y aún aumentaba al año.
- Acné, el exceso más claro sobre placebo; un año de seguridad es poco para un JAK.

¿Qué aprendí de investigación?

- Desenlace de respondedores: claro, pero pierde información.
- La forma de imputar los faltantes puede mover el resultado.
- Con placebo bajo, OR y RR oscilan; si el evento no es raro, el OR exagera el RR: usa diferencia absoluta y NNT.
- Dos ensayos gemelos replican; un análisis *post hoc* no prueba.

6 Referencias

1. Ezzedine K, Lui H, Eleftheriadou V, Desai SR, Passeron T, Ringuet J, et al. Povorcitinib for nonsegmental vitiligo: two randomized, controlled, phase 3 STOP-V trials. Nat Med. 2026. doi:10.1038/s41591-026-04739-2

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.